

INTOX. PEDIÁTRICA — ABC + ANTÍDOTO + CEATOX

ABORDAGEM GERAL

Etapa	Conduta
Estabilizar (ABC)	Via aérea, ventilação e circulação primeiro; glicemia capilar em todo rebaixamento
Identificar o agente	O que, quanto, quando e via; trazer a embalagem; contatar o CEATOX/centro de toxicologia
Descontaminação	Carvão ativado em casos selecionados (ver abaixo); NÃO induzir vômito
Antídoto	Quando disponível e indicado (ver tabela de antídotos)
Eliminação	Alcalinização urinária, hemodiálise em toxinas específicas
Observação/segurança	Avaliar tempo de observação; sempre considerar maus-tratos/negligência e prevenir recorrência

DESCONTAMINAÇÃO — O QUE MUDOU

NÃO INDUZIR VÔMITO; CARVÃO ATIVADO É SELETIVO

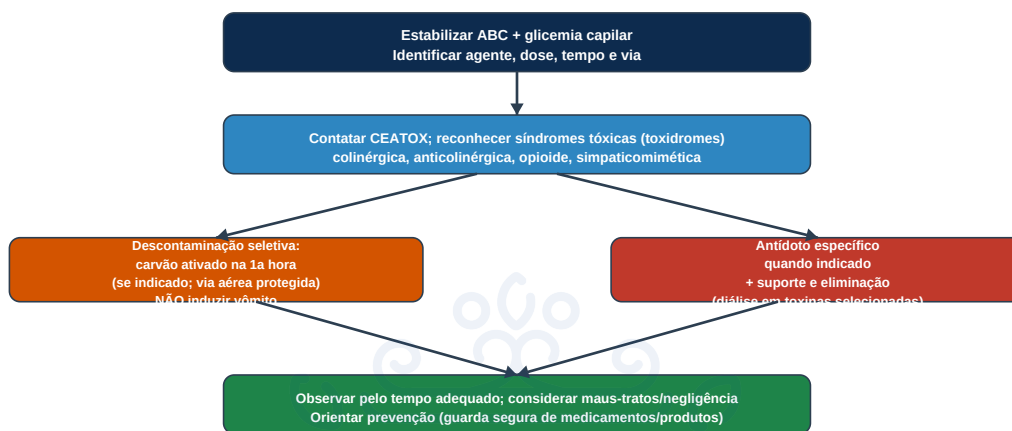
- NÃO induzir vômito (xarope de ipeca está abandonado) — risco de aspiração e sem benefício
- Carvão ativado: 1 g/kg VO, mais útil na PRIMEIRA HORA pós-ingestão de dose tóxica de substância que ele adsorve
- Carvão NÃO adsorve: metais (ferro, lítio), álcoois, hidrocarbonetos, cáusticos — não usar nesses casos
- Contraindicações ao carvão: via aérea desprotegida (rebaixamento sem IOT), íleo/obstrução, ingestão de cáustico
- Lavagem gástrica: raramente indicada (apenas situações muito selecionadas e precoces)
- Cáusticos e hidrocarbonetos: NÃO induzir vômito, NÃO dar carvão, NÃO neutralizar — suporte e avaliação especializada
- Contatar sempre o centro de toxicologia (CEATOX) para orientação específica

ANTÍDOTOS PRINCIPAIS

Tóxico	Antídoto	Observação
Paracetamol	N-acetilcisteína	Guiar pelo nomograma; eficaz se precoce
Opioides	Naloxona	Reverter depressão respiratória
Benzodiazepínicos	Flumazenil	Cautela: risco de convulsão (uso crônico/coingestão)
Organofosforados	Atropina + pralidoxima	Síndrome colinérgica (SLUDGE), broncorreia
Ferro	Desferroxamina	Carvão NÃO adsorve ferro
Metanol/etilenoglicol	Fomepizol (ou etanol) + diálise	Acidose com GAP/osmolar elevado
Betabloqueador/BCC	Glucagon / cálcio / insulina em dose alta	Bradicardia e hipotensão

ABORDAGEM DA CRIANÇA INTOXICADA

INTOX. PEDIÁTRICA — ABC + IDENTIFICAR + ANTÍDOTO



TOXIDROMES E AGENTES COMUNS NA INFÂNCIA

Síndromes Tóxicas (Toxidromes)

- Colinérgica (organofosforado): miose, salivação, lacrimejamento, diarreia, broncorreia, bradicardia
- Anticolinérgica (antihistamínico, atropínicos): midríase, pele seca e quente, taquicardia, delírium, retenção urinária
- Opióide: miose, depressão respiratória, rebaixamento
- Simpaticomimética (cocaína, anfetamina): midríase, taquicardia, HAS, agitação, hipertermia
- Sedativo-hipnótica (BZD, álcool): rebaixamento, fala arrastada

Agentes Frequentes em Casa

- Medicamentos dos pais/avós (anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, psicotrópicos)
- Paracetamol e outros analgésicos
- Produtos de limpeza/cáusticos (soda, desinfetantes)
- Hidrocarbonetos (querosene, gasolina) — risco de pneumonite
- Raticidas, pesticidas (organofosforados)
- Plantas e cosméticos

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Estabilizar ABC e checar glicemia em todo rebaixamento
- ☐ Identificar agente, dose, tempo e via; contatar o CEATOX
- ☐ Reconhecer toxidromes para guiar a conduta e o antídoto
- ☐ Carvão ativado seletivo (1ª hora, via aérea protegida); NÃO induzir vômito; sem carvão em cáustico/hidrocarboneto/metais/álcoois
- ☐ Antídoto específico quando indicado (N-acetilcisteína, naloxona, atropina+pralidoxima, etc.)
- ☐ Observar pelo tempo adequado, considerar maus-tratos/negligência e orientar prevenção

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

SBP / Adaptada

Criança ingeriu soda cáustica há 30 minutos. Qual conduta é CORRETA?

- A) Induzir o vômito imediatamente
- B) Administrar carvão ativado
- C) NÃO induzir vômito, NÃO dar carvão nem neutralizar; suporte e avaliação especializada (risco de lesão esofágica)
- D) Neutralizar com vinagre
- E) Lavagem gástrica imediata

QUESTÃO 2

FMUSP / Adaptada

Sobre o carvão ativado na intoxicação pediátrica, qual afirmação é correta?

- A) Adsorve ferro, lítio e álcoois com eficácia
- B) É mais útil na primeira hora, em dose tóxica de substância adsorvível, com via aérea protegida
- C) Deve ser dado a toda criança intoxicada
- D) É indicado mesmo com rebaixamento e via aérea desprotegida
- E) Substitui o antídoto específico

QUESTÃO 3

AMRIGS / Adaptada

Criança com miose, salivação intensa, broncorreia, diarreia e bradicardia após contato com pesticida. Qual a toxidrome e o antídoto?

- A) Anticolinérgica — fisostigmina
- B) Colinérgica (organofosforado) — atropina + pralidoxima
- C) Opióide — naloxona
- D) Simpaticomimética — betabloqueador
- E) Sedativa — flumazenil

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual é o antídoto da intoxicação por paracetamol?

- A) Naloxona
- B) N-acetilcisteína
- C) Flumazenil
- D) Atropina
- E) Desferroxamina

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Sobre a indução de vômito (ex.: xarope de ipeca) na criança intoxicada, qual afirmação é correta?

- A) Deve ser feita de rotina em todas as ingestões
- B) Está abandonada — não se induz vômito (risco de aspiração e sem benefício comprovado)
- C) É indicada em ingestão de cáusticos
- D) Substitui o carvão ativado
- E) É o método de escolha para hidrocarbonetos

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Na ingestão de cáustico, NÃO se induz vômito (reexpõe o esôfago ao agente), NÃO se dá carvão (não adsorve e atrapalha a endoscopia) e NÃO se neutraliza (reação exotérmica). A conduta é suporte, analgesia e avaliação especializada (endoscopia) pelo risco de lesão esofágica.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O carvão ativado é mais útil na primeira hora após a ingestão de dose tóxica de uma substância que ele adsorve, com a via aérea protegida. Não adsorve metais (ferro, lítio), álcoois, hidrocarbonetos nem cáusticos, e é contraindicado com via aérea desprotegida.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Miose, salivação, broncorreia, diarreia e bradicardia (síndrome colinérgica, mnemônico SLUDGE) após pesticida indicam intoxicação por organofosforado. O tratamento é atropina (antagoniza o efeito muscarínico) + pralidoxima (reativa a acetilcolinesterase).

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O antídoto da intoxicação por paracetamol é a N-acetilcisteína, guiada pelo nomograma e mais eficaz quanto mais precocemente administrada, prevenindo a hepatotoxicidade.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A indução de vômito (xarope de ipeca) está abandonada: não há benefício comprovado e há risco de aspiração. É especialmente perigosa em cáusticos e hidrocarbonetos. A descontaminação atual se baseia no carvão ativado seletivo.

SM24
Suporte ao Plantão Médico